

ADVERTENCIA

Este documento es de carácter PÚBLICO MILITAR y el conocimiento de su contenido está limitado al personal perteneciente al Instrumento Militar (ROP 11 - 06 Art 7.008).

Copia Nro:
SGE
CABA
24 May 23
AEB - 017

DIRECTIVA DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD Nro 01/23 (Prevención del comportamiento suicida en el personal del Ejército Argentino).

1. SITUACIÓN

El suicidio es un grave problema de salud pública, consistente en un acto deliberado por el que una persona se quita la vida voluntariamente.

El intento de suicidio es un acto de autodestrucción con resultado no fatal, a menudo con el propósito de solicitar ayuda, siendo el factor de riesgo individual más importante para la consumación del suicidio.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL ARGENTINA, EL SUICIDIO NO ESTÁ CONSIDERADO COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL Y, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA LEY PARA EL PERSONAL MILITAR, NO GUARDA RELACIÓN CON LOS ACTOS DE SERVICIO".

En la República Argentina, durante el año 2021 se registraron 3.649 suicidios, arrojando una tasa de 8,7 suicidios cada 100 mil habitantes mayores a 5 años. Debido al aumento en los casos y en la tasa respecto a 2020, en 2021 volvió a ser la segunda causa de muerte violenta en el país, acumulando el 36,1% de las muertes violentas.

La mayor cantidad de suicidios lo cometen personas entre los 15 y 29 años, la mayoría son varones (80%), y el lugar donde se lleva a cabo es, en general, el domicilio (74%).

La ingestión de sustancias tóxicas (venenos, etc), el ahorcamiento y el uso de armas de fuego son los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo.

Debido a la situación expresada precedentemente la Fuerza lleva adelante distintos procedimientos orientados a:

- a) Analizar y detectar los potenciales factores de riesgo inminentes que podrían ocasionar conductas de autodestrucción, suicidas o parasuicidas, dentro del Reconocimiento Médico/Psicológico que se efectúa dentro del proceso de reclutamiento de la Fuerza y al Personal militar en condición de ascenso.

- b) Dar a conocer y brindar herramientas de comunicación al alcance del personal que solicite apoyo.
- c) Realizar evaluación en momentos de alta vulnerabilidad.
- d) Derivación oportuna al Área de Salud Mental/Psiquiatría a través de la Obra Social.

2. FINALIDAD

Brindar herramientas que permitan monitorear y establecer acciones ante aquellos casos de suicidio e intento de suicidio en el personal, a través de guías estandarizadas para la detección oportuna de conductas de riesgo, acceso a prestaciones de salud, resguardar los procedimientos establecidos dentro de los marcos institucionales y la disminución de casos en la Fuerza.

3. VIGENCIA

La presente Directiva tendrá vigencia a partir de su aprobación y difusión a toda la Fuerza.

4. ALCANCE

La presente Directiva es para conocimiento y cumplimiento de todo el Personal Militar y Civil de la Fuerza.

5. MARCO LEGAL

La presente Directiva se encuentra regulada por las siguientes normativas:

- a. Ley N° 27.130/2015 "Ley Nacional de Prevención de Suicidio".
- b. Ley N° 26.657 /2010 "Ley de Salud Mental".
- c. Ley 25.421/2001 "Programa de Asistencia Primaria de Salud Mental".
- d. RFD 23-02. Régimen Funcional de Sanidad.
- e. OE JEMGE 1094/15. Implementación del Legajo Psicológico-Psiquiátrico.
- f. Directiva Técnica del Director General de Salud Nro 441/21 (Para el reconocimiento médico del Servicio militar voluntario).
- g. Directiva Técnica del Director General de Salud Nro 443/21 (Ex. Médico Periódico).
- h. **Deroga la Directiva Técnica particular de la Dirección General de Salud Nro 04/16 (Prevención del suicidio).**

6. OBSERVATORIO DEL SUICIDIO.

Teniendo presente la problemática de salud, se creará el "Observatorio del Suicidio", equipo interdisciplinario con asiento en la Dirección General de Salud (Integrado por profesionales psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, abogados, entre otros), que será el equipo institucional de referencia sobre la problemática en cuestión. Tendrá funciones fijas a desarrollar desde el lugar de destino profesional y otras itinerantes relacionadas con la temática en las distintas guarniciones. Será un equipo ad hoc, con recursos humanos disponibles en la Fuerza.

Sus funciones consistirán en: asesoramiento profesional a los Jefes; contacto con familiares; contención del personal; asistencia y/o derivación de casos de intentos de suicidio o conductas de riesgo; monitoreo de casos; recopilación de información y generación de estadísticas. De forma itinerante, realizará acciones de prevención primaria tales como: la organización y ejecución de talleres, charlas, y la elaboración de estrategias de ayuda para su difusión.

7. PROCEDER ANTE CASOS DE SUICIDIO E INTENTOS DE SUICIDIO.

a. Ante un caso de supuesto suicidio.

1) Aislar y proteger el lugar del hecho:

Ante un incidente de este tipo, se debe aislar y proteger el lugar del hecho de inmediato, a la espera de las instrucciones de la autoridad judicial a cargo. Independientemente del lugar y de la identidad de la víctima, el cuerpo no debe ser movido por terceras personas, a menos que aun tenga signos vitales, procediendo a dar cuenta en forma inmediata a la cadena de comando por los canales establecidos. (Parte circunstanciado CENOPE)

Debe tenerse en cuenta que la causa de la muerte será definida por las autoridades judiciales, más allá que inicialmente se presuma que la acción que ha causado la muerte haya sido suicidio.

2) Realizar Denuncia:

La comunicación del hecho a la autoridad judicial correspondiente es responsabilidad del Jefe de Elemento, debe comunicar a la guardia qué organismos policiales y judiciales han sido autorizados para ingresar al cuartel para ejecutar el procedimiento legal correspondiente, adoptando todas las medidas para mantener el estado de normalidad en todas las actividades de la unidad.

3) Iniciar las actuaciones administrativas correspondientes:

Dada la gravedad y posibles repercusiones de estos casos, será el Oficial de Personal del Elemento, el encargado de recopilar los antecedentes y elaborar los informes respectivos, siendo el Jefe de Elemento el que tendrá la obligación de ordenar la instrucción de las actuaciones administrativas correspondientes.

4) Comunicar lo sucedido:

Será de responsabilidad del Jefe de Elemento del fallecido comunicar el fallecimiento a familiares directos en un plazo no superior a 2 horas de conocido el hecho. La comunicación deberá efectuarse con especial atención, considerando que el acto de comunicar un hecho como el descrito reviste ciertos cuidados, se deberán seguir los siguientes pasos:

a) Tomar contacto con los parientes directos (cónyuge, conviviente civil, padres, tutores, representante legal, entre otros) que sean mayores de edad. Si estos residen en la misma zona geográfica que la persona fallecida, el Jefe de Elemento deberá comunicar el deceso. Si el cónyuge, conviviente o familiares directos tuvieran residencia fuera de la localidad, deberán ser comunicados mediante vía telefónica para dar prontitud a la entrega de información.

b) Para los casos en que la comunicación de los hechos sea presencial, el Jefe de Elemento debe concurrir al domicilio del o los familiares directos acompañado de personal de Sanidad, ante la posibilidad de que algún familiar requiera de atención al recibir la noticia.

c) Para aquellos casos en que la comunicación de los hechos sea vía telefónica, se sugiere el siguiente texto como guía:

"Estimada(o) Sr. (a), soy... (grado, nombre y cargo) y es mi deber comunicarle el sensible fallecimiento de su (hijo, hija, cónyuge u otro) ...del cual acabo de tomar conocimiento, hecho que se encuentra en plena investigación. Sepa Ud. que cuenta con todo el apoyo de la Institución, por lo que un oficial de enlace designado (grado, nombre y cargo), tomará contacto con Ud. a la brevedad, con la finalidad de apoyarla(o) en todas las gestiones que se estimen necesarias y que sean pertinentes, ante este lamentable hecho".

d) En el caso que la comunicación de los hechos sea presencial, esta debe ser realizada en un ambiente privado, resguardando la reserva de la situación, silenciando los dispositivos móviles y teléfonos fijos para generar un ambiente de respeto hacia los familiares y, en la medida de lo posible, asegurarse de no ser interrumpido.

e) La actitud hacia los familiares debe reflejar comprensión y empatía, mencionando el nombre de la persona fallecida y narrando brevemente los hechos.

En lo posible, se evitará emplear frases hechas como "sé cómo se sienten en este momento" o "tienen que ser fuertes"; será conveniente utilizar frases que inicien con expresiones tales como "me imagino...", "entiendo..." y "claro...".

- f) El lenguaje utilizado debe ser claro y preciso, considerando no emplear supuestos ni antecedentes sobre los que no se tiene certeza, usando un tono de voz amable y comprensivo. El contacto humano, un abrazo, un apretón de manos o una mano encima del hombro podría ser bien valorado por las personas que reciban la noticia. Se sugiere la utilización del siguiente relato:

"Estimado/a Sr. (a), soy... (grado, nombre y cargo) y es mi deber comunicarle el sensible fallecimiento de su (hijo, hija, cónyuge u otro) ...del cual acabo de tomar conocimiento, hecho que se encuentra en plena investigación. Sepa Ud. que fui nombrado/a por la Institución para hacerle llegar todo el apoyo y la ayuda que sea necesaria."

- g) Permitir un tiempo razonable a la familia para que comprendan, asimilen la información y reaccionen, dándoles la oportunidad de hacer preguntas, escuchar sin interrumpirlos, ayudando a que se expresen o respetando su silencio.
- h) Facilitar las llamadas telefónicas u ofrecer ayuda para comunicarle los hechos a otros familiares.
- i) Apoyar en la gestión de los trámites administrativos y explicar cuáles son.

5) Lineamientos generales para el manejo de la información:

Resulta de vital importancia el manejo adecuado de la información en este tipo de situaciones, lo que permitirá, por una parte, proteger a los afectados de la exposición pública, y por otra, evitar el tratamiento inadecuado de los aspectos comunicacionales. Se deberá considerar lo siguiente:

- a) Ante la ocurrencia de un hecho de estas características el Jefe de Elemento debe contactarse con la Secretaría General del Ejército, a fin de ser asesorado convenientemente al respecto de las acciones a desarrollar desde el punto de vista comunicacional.
- b) Al ocurrir un suicidio al interior de una unidad militar y ante los diversos cuestionamientos de los medios de comunicación, los Jefes de Elemento se verán en la obligación de informar a la opinión pública lo sucedido.
- c) En el caso que la situación se pueda manejar mediante un comunicado / gaceta de prensa, este debe contener solo los antecedentes precisos, es decir: lo ocurrido (aparente suicidio), dónde (interior de la unidad) y lo que está realizando la unidad al respecto (informar a las autoridades pertinentes, ini-

ciar investigación y apoyo correspondiente a los familiares). Se recomienda finalizar este documento con un párrafo en el cual la unidad lamente profundamente el hecho que involucra a uno de sus integrantes. También se recomienda evitar hacer juicios de valor, opiniones o reflexiones respecto a las posibles causas que llevaron a tomar la determinación de quitarse la vida.

d) Si debido al impacto mediático que ha generado la situación se decide efectuar declaraciones a la prensa, las mismas deben ceñirse a los mismos puntos señalados por el comunicado oficial. De esta manera, ante las preguntas de los medios de comunicación, las respuestas deben mantenerse en las "ideas fuerza" establecidas. Al mismo tiempo, evitar juicios de valor, opiniones o reflexiones respecto a las posibles causas de suicidio.

e) Se debe prohibir la entrega de fotografías del fallecido a la prensa.

b. Acciones a desarrollar luego de ocurrido un suicidio.

Tras un suicidio podría aumentar el riesgo de intento suicida en las personas cercanas al fallecido, por un efecto postraumático similar a un "contagio". De este modo es muy probable que en las unidades afectadas por el suicidio de uno de sus integrantes aumente el riesgo, así como las consultas médicas relativas a la salud mental.

La aplicación de medidas de vigilancia, la restricción de acceso a medios letales, reducir el estigma de las personas que reciben atenciones en salud mental, fomentar la sensibilización sobre la problemática en el personal, son acciones que contribuirán a disminuir el impacto de este tipo de situaciones.

Será de suma importancia recibir el asesoramiento de especialistas capacitados (Observatorio del suicidio – DGS).

c. Acciones preventivas.

Es sumamente necesario y mandatorio ayudar a la persona potencialmente suicida. Ante la mínima sospecha, se informará la situación al Personal de Sanidad quien solicitará (si lo considera pertinente) la derivación urgente al Área de Salud Mental correspondiente.

Un Jefe podrá tener un conocimiento más exacto de las reacciones de sus hombres y de su probable comportamiento en diferentes condiciones ambientales, en la medida que obtenga éxito en la observación consciente, profunda y detallada de és-

tos. Tal procedimiento le permitirá comprenderlos mejor y reconocer sus particularidades, diferencias, virtudes y defectos.

1) Identificación de Factores de riesgo:

- a) **Alteración en la estructura familiar.**
- b) **Bajo nivel socioeconómico.**
- c) **Bajo nivel educativo / instructivo.**
- d) **Trastornos psiquiátricos.**
- e) **Trastornos del estado de ánimo.**
- f) **Crisis de angustia.**
- g) **Abuso de sustancias.**
- h) **Trastornos de la personalidad.**
- i) **Esquizofrenia.**
- j) **Trastornos de la conducta alimentaria.**

Existen además factores psicológicos de la conducta suicida, principalmente el sentimiento de desesperanza y de culpabilidad.

2) Identificar las señales de advertencia de un potencial suicida:

- a) **Aislamiento social.**
- b) **Sentimientos de fracaso.**
- c) **Inutilidad.**
- d) **Desesperanza y pérdida de la autoestima.**
- e) **Mayor excitabilidad.**
- f) **Irritabilidad e insatisfacción.**
- g) **Impulsividad o agresión.**
- h) **Sueño fragmentado.**
- i) **Problemas sin solución según su perspectiva, hasta la ideación suicida.**
- j) **Existen situaciones laborales, personales y/o familiares que se deberán tener en cuenta, por ejemplo: una pérdida reciente de una relación cercana, un cambio radical en las circunstancias de trabajo (baja, retiro próximo), evento**

serio y/o vergonzoso relacionado con el trabajo, cambio en su salud, abuso de alcohol u otras drogas, formas de depresión y/o trastornos de adaptación, desgaste laboral o fatiga inexplicable (Síndrome de Burnout).

d. Ante un caso de intento de suicidio.

- 1) Es responsabilidad de los Jefes de Unidad, comunicar a la autoridad judicial competente los casos de "Intentos de Suicidio" sucedidos en la Unidad militar, y de los que tomare conocimiento en ejercicio de sus funciones.
- 2) En este orden de ideas y en base a lo normado por la Ley 27.130 "Ley Nacional de Prevención del Suicidio Art 13) "Todas las personas que, en el marco de la asistencia y el tratamiento de un paciente que haya intentado suicidarse, hayan tomado contacto o conocimiento del mismo, estarán obligadas a la confidencialidad de la información.", se deberá prestar especial atención a mantener la confidencialidad del individuo que cometiere el intento autolesivo.
- 3) Frente a un riesgo inminente de suicidio, se debe solicitar ayuda en forma inmediata, llevando al afectado a atención médica y/o un servicio de urgencia y mientras tanto:
 - No dejarlo solo, es necesario que la persona en riesgo se sienta acompañada.
 - No hacerlo sentir culpable.
 - No desestimar sus sentimientos.
 - Expresarle apoyo y comprensión.
 - Permitirle la expresión de sentimientos.
- 4) Lo fundamental es mantener con vida a la persona en riesgo hasta que pase la crisis; por lo cual es necesaria la asistencia de todas las personas capacitadas para ello, teniendo presente lo siguiente:
 - Siempre hay que creerle a la persona que manifiesta la intención o ideación suicida.
 - No se deben banalizar ni despreciar las amenazas suicidas, como tampoco pensar que lo que quiere es llamar la atención. Un porcentaje importante del personal que se han suicidado habían expresado sus ideas de suicidio previamente, por lo tanto, cualquier amenaza de suicidio debe ser tomada en serio.
 - No dejarla sola y tratar de llevarla a la enfermería para evaluación médica o servicio de urgencia hospitalaria, enfatizando la necesidad de recibir ayuda.

- Tomar medidas para disminuir los riesgos, alejando los objetos que puedan servir para realizar el acto suicida (esto incluye armamento, armas blancas, explosivos, cuerdas y medicamentos, entre otros).
- Generar un espacio de confianza, de escucha y de contención.
- No ser críticos frente a la situación.
- Reforzar los recursos de la persona, su potencial de vida.
- Garantizar la seguridad personal.
- Ayudar a que la persona exprese sus sentimientos.

5) Será de suma importancia recibir el asesoramiento de especialistas capacitados (Observatorio del suicidio – DGS).

8. COMANDO Y COMUNICACIONES

a. DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

Calle 15 de noviembre de 1889 – Nro. 1932 C.P. 1261

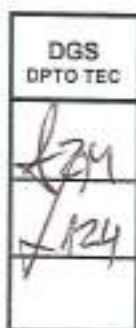
b. COMUNICACIONES

TELÉFONOS: (011) 4306 8011 y 43063270- interno 208.

CORREO ELECTRÓNICO: dptotecnicosan@yahoo.com.ar

ANEXOS:

- Anexo 1: Procedimientos administrativos.
- Anexo 2: Guía estandarizada para Jefes de Elemento.
- Anexo 3: Tutoría de Prevención.
- Anexo 4: Estadísticas para la prevención del suicidio.



General de Brigada JAVIER ALBERTO PALAZON
DIRECTOR GENERAL DE SALUD

ADVERTENCIA

Este documento es de carácter **PÚBLICO MILITAR** y el conocimiento de su contenido está limitado al personal perteneciente al Instrumento Militar (ROP 11 - 06 Art 7.008).

Copia Nro:
SGE
CABA
24 May 23
AEB - 017

ANEXO 1 (Procedimientos administrativos) a la DIRECTIVA DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD Nro 01/23 (Prevención del comportamiento suicida en el personal del Ejército Argentino).

1) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

- a. Todo personal militar o civil que curse o evidencie intento de suicidio será excluido de **toda actividad**. Ante un suceso de intento de suicidio o suicidio, el Jefe del Elemento de Sanidad, debe comunicarse en forma inmediata con el Observatorio del Suicidio para ser asesorado y guiado en las acciones previas a los procedimientos administrativos como ser la derivación a Centros de Salud.
- a. Se le otorgará "**Parte de Enfermo**" en el domicilio/casino, y se confeccionará la documentación reglamentaria que corresponda para su derivación y atención en el Dpto de Psicopatología del HMCM hasta tanto se expida la Junta de Calificaciones sobre su situación de revista.
- b. La derivación al HMCM se realizará con UN (1) acompañante del elemento, a fin de dar el mayor apoyo y contención social (Art 30 - Ley 26.657 "Ley Nacional de Salud Mental"). El acompañante será un superior del causante, quién deberá acompañarlo en todo momento, siendo responsable de la tramitación de la documentación que se origine.
- c. Una vez coordinada la fecha de derivación, el Jefe del Servicio de Sanidad del Organismo de revista del causante confeccionará un **Anexo 40 "Solicitud de Prestación e Informe"** reglamentario **sin excepción** (Art 7 - Ley 26.657 - "Ley Nacional de Salud Mental"), debiendo colocar como diagnóstico: **CIE 10 X60-X84**
- d. El Anexo 40 deberá tener el mismo número de expediente que el organismo de revista del causante, le asignó a la actuación por enfermedad.
- e. Los gastos de traslado del causante y su acompañante se tramitarán por el SIGIT con cargo al Elemento de revista del Causante.
- f. El alojamiento y racionamiento del causante y su acompañante será brindado por la Dirección de Educación Operacional (DEOP), quien requerirá a la DGOD las raciones correspondientes.
- g. Las Actuaciones Administrativas por Enfermedad son las correspondientes a la "Reglamentación para el Ejército de la Ley para el Personal Militar Nro 19.101", Tomo IV - "Retiros y Pensiones".
- h. La Actuación deberá mantener la clasificación de **CONFIDENCIAL** y el labrado de la información por el Oficial Informante, deberá ser tramitada y con posteriormente remitida a la **JUNTA MÉDICA SUPERIOR PARA PERSONAL**

MILITAR (JMSPM), en un plazo NO mayor a los TREINTA (30) días desde el inicio de la Actuación.

2. DEPARTAMENTO DE PSICOPATOLOGÍA Y SALUD MENTAL DEL HOSPITAL MILITAR "CAMPO DE MAYO" PARA CON EL PERSONAL DERIVADO.

- a. El Departamento de Psicopatología y Salud Mental del HMCM será el único servicio de la Fuerza, que realizará la **evaluación diagnóstica y codificación médica**.
- b. Asimismo, completará el Anexo 40, el cual será entregado al acompañante institucional en sobre cerrado y bajo continuación de Nro de Expediente.
- c. La permanencia estimada del personal para su evaluación, diagnóstico y clasificación será de 72 horas (hábiles). Por regla general, las evaluaciones se inician lunes o miércoles con una entrevista médica para continuar al día siguiente con las pruebas psicológicas, aspecto que deberá ser tenido en cuenta al solicitar la derivación.
- d. El Departamento de Psicopatología y Salud Mental del HMCM, **SE LIMITARÁ A DAR EL DIAGNÓSTICO Y CODIFICACIÓN MÉDICA.**
- e. La Aptitud para el Servicio será **"A determinar por Junta" JUNTA MÉDICA SUPERIOR PARA PERSONAL MILITAR (JMSPM), sin excepción.**

3. CON POSTERIORIDAD A LA EVALUACIÓN/DIAGNÓSTICO Y CODIFICACIÓN DEL PERSONAL DE CUADROS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PSICOPATOLOGÍA Y SALUD MENTAL DEL HOSPITAL MILITAR "CAMPO DE MAYO".

- a. Una vez finalizada la evaluación/diagnóstico y codificación médica, el causante regresará a su Organismo de revista, llevando el acompañante en sobre cerrado "Confidencial Médico" el Anexo 40 - "Solicitud de Prestación e Informe" debidamente cumplimentado con diagnóstico, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) correspondiente y evaluaciones realizadas en forma detallada.
- b. El médico del Organismo de revista, al recibir el Anexo 40 comunicará al causante de los procedimientos a seguir para recibir asistencia a través de la obra social, en caso de que le corresponda continuar afiliado a la misma y siempre que éste lo solicite.
- c. Si el causante hubiese aceptado la asistencia por parte de la obra social, el médico deberá recabar, en forma mensual, un informe de evolución del tratamiento al centro tratante, el cual será anexado al Legajo del causante para su posterior empleo por parte de la **JUNTA MÉDICA SUPERIOR PARA PERSONAL MILITAR (JMSPM)**. Estas acciones no interrumpen la tramitación de las Actuaciones, ni debe incrementar el plazo establecido en el presente Apéndice.
- d. Teniendo en cuenta que la Ley 26.657 "Ley de Salud Mental", ampara la identidad del personal afectado (Art. 7, Inc. b) y que hasta la actualidad no existe una normativa sanitaria de cómo codificar estos casos, a todo efecto se codificará la documentación sanitaria del siguiente modo:

PÚBLICO MILITAR

Las DOS (2) primeras letras del primer nombre y las DOS (2) primeras letras del primer apellido tal como figuran en el DNI seguidos de los TRES (3) últimos números del DNI. **Ejemplo: JUAN PEREZ DNI 25.101.123 será JUPE123 y el Código del Organismo de revista, JUPE123U4567.**

- e. En el Organismo del causante se dará continuación a las actuaciones manteniendo la clasificación de **CONFIDENCIAL**, debiendo el Oficial Informante consignar que deberán ser tramitadas con carácter de **"MUY URGENTE"**, por lo cual serán elevadas al escalón superior en un lapso NO mayor a las **48 horas**.
- f. Dicha documentación sólo seguirá la cadena de comando hasta el nivel Brigada o equivalente, siendo este nivel, el responsable de controlar que la documentación se encuentre completa y que sea remitida a la **JUNTA MÉDICA SUPERIOR PARA PERSONAL MILITAR (JMSPM)**.
- g. La **JUNTA MÉDICA SUPERIOR PARA PERSONAL MILITAR (JMSPM)** remitirá su Informe Médico Legal (IML), con la clasificación "Disminuido en sus Aptitudes Físicas" (DAF) o "Inútil Todo Servicio" (ITS) a la Gran Unidad o equivalente para el caso de SSVV y para el caso de Cuadros al Dpto Registro e Informes (Dir Pers Mil), dentro de los **CATORCE (14) días corridos desde que la JUNTA MÉDICA SUPERIOR PARA PERSONAL MILITAR (JMSPM) haya recibido las Actuaciones**.
- h. Asimismo, la **JUNTA MÉDICA SUPERIOR PARA PERSONAL MILITAR (JMSPM)** tras emitir su Informe Médico Legal (IML) y en caso de que la clasificación DAF/ITS, fuese por causa de Adicciones/Consumo de estupefacientes, podrá determinar que dicho personal NO pase al Escalafón Complementario.
- i. Recepcionado el IML y su clasificación, la División Personal y la Asesoría Jurídica de la Gran Unidad de Combate o equivalente (para SSVV) y la **DGAJ** (para Cuadros), cumplimentará con el respectivo acto administrativo con la finalidad de posibilitar la resolución correspondiente por parte de la autoridad competente.
- j. Las actuaciones por enfermedad deben concluir con el respectivo acto administrativo dictado por autoridad competente.

DGS
DPTO TEC
874
124



General de Brigada JAVIER ALBERTO PALAZON
DIRECTOR GENERAL DE SALUD

PÚBLICO MILITAR

ADVERTENCIA

Este documento es de carácter **PÚBLICO MILITAR** y el conocimiento de su contenido está limitado al personal perteneciente al Instrumento Militar (ROP 11 - 06 Art 7.008).

Copia Nro:
SGE
CABA
24 May 23
AEB - 017

ANEXO 2 (Guía estandarizada para Jefes de Elementos / Unidades / Subunidades Independientes) A LA DIRECTIVA DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD Nro 01/ 23 (Prevención del comportamiento suicida en el personal del Ejército Argentino).

Datos a ser elevados a la DGS – Observatorio del suicidio.

1. INTENTOS DE SUICIDIOS.

Datos del Elemento:

- a. Unidad:
- b. Provincia:

Datos del hecho:

- a. Breve descripción del suceso:
- b. Día de la semana:
- c. Mes:
- d. Hora:
- e. Lugar (Unidad, domicilio particular, domicilio particular en barrio militar, vía pública, otro)
- f. Mecanismo utilizado (En caso de arma de fuego, especificar si es provista por la Fuerza)

Datos personales del causante:

- a. Nombre y Apellido - DNI:
- b. Edad:
- c. Sexo:
- d. Nivel de educación:
- e. Situación personal
 - Estado civil, hijos, otros:
 - Otras observaciones (en caso de conocer, especifique si atraviesa alguna crisis, duelo, situación de violencia doméstica, consumo problemático, etc.):
- f. Antecedentes de salud que considere relevantes (especificar, en caso de conocer, si cursa algún tratamiento):
- g. Intentos previos de suicidio:

Situación del causante en la Fuerza:

- a. Escalafón:
- b. Grado:
- c. Antigüedad en la Fuerza:
- d. Tiempo en el destino:
- e. Rendimiento:
- f. Otras observaciones:

2. SUICIDIOS.

Datos del Elemento:

- a. Unidad:
- b. Provincia:

Datos del hecho:

- a. Breve descripción del suceso:
- b. Día de la semana:
- c. Mes:
- d. Hora:
- e. Lugar (Unidad, domicilio particular, domicilio particular en barrio militar, vía pública, otro)
- f. Mecanismo utilizado (En caso de arma de fuego, especificar si es provista por la Fuerza):

Datos personales del causante:

- a. Nombre y Apellido - DNI:
- b. Edad:
- c. Sexo:
- d. Nivel de educación:
- e. Situación personal:
- Estado civil, hijos, otros:
- Convivientes:
- Otras observaciones (en caso de conocer, especifique si atravesaba alguna crisis, duelo, situación de violencia doméstica, consumo problemático, etc.):
- f. Antecedentes de salud que considere relevantes (especificar, en caso de conocer, si cursaba algún tratamiento):
- g. Intentos previos de suicidio:

Situación del causante en la Fuerza:

- a. Escalafón:
- b. Grado:
- c. Antigüedad en la Fuerza:
- d. Tiempo en el destino:
- e. Rendimiento:
- f. Otras observaciones en relación al trabajo: desempeño, relaciones interpersonales, otros:

DGS
Dpto Tec
139
124



General de Brigada JAVIER ALBERTO PALAZON
DIRECTOR GENERAL DE SALUD

PÚBLICO MILITAR

ADVERTENCIA

Este documento es de carácter PÚBLICO MILITAR y el conocimiento de su contenido está limitado al personal perteneciente al Instrumento Militar (ROP 11 - 06 Art 7.008).

Copia Nro: ,
SGE
CABA
24 May 23
AEB - 017

ANEXO 3 (Tutoría de Prevención) A LA DIRECTIVA DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD Nro 01/ 23 (Prevención del comportamiento suicida en el personal del Ejército Argentino).

La derivación al HMCN se realizará con UN (1) acompañante del elemento, a fin de dar el mayor apoyo y contención social (Art 30 - Ley 26.657 "Ley Nacional de Salud Mental"). El acompañante será un superior del causante, quién deberá acompañarlo en todo momento, siendo responsable de la tramitación de la documentación que se origine".

DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL TITULAR:

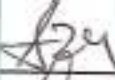
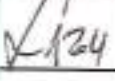
1. Grado:
2. Unidad / Destino:
3. Nombre y Apellido del Titular:
4. Domicilio:
5. Teléfono:
6. ¿A quién quiere avisar en caso de necesitar apoyo por tener dificultades que afecten sus actividades diarias? Informe teléfono y domicilio.
.....
7. ¿Posee antecedentes de asistencia psicológica y/o psiquiátrica en el último año?
.....
8. En caso de contestar "SI" en la pregunta anterior indique nombre del profesional tratante, dirección o teléfono.
.....
.....
.....

DESIGNACIÓN DEL TUTOR MILITAR

(Debe ser una persona en actividad de la misma Unidad) **Es obligatorio completarlo.**

1. Grado:
2. Destino Interno:
3. Nombre y Apellido del Titular:
4. Domicilio:
5. Teléfono:

.....
Firma y aclaración del tutor militar

DGS Dato Tec





General de Brigada JAVIER ALBERTO PALAZON
DIRECTOR GENERAL DE SALUD

PÚBLICO MILITAR

ADVERTENCIA
Este documento es de carácter PÚBLICO MILITAR y el conocimiento de su contenido está limitado al personal perteneciente al Instrumento Militar (ROP 11 - 06 Art 7.008).

Copia Nro:
SGE
CABA
24 May 23
AEB - 017

ANEXO 4 (Estadísticas para la prevención del suicidio) DIRECTIVA DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD Nro 01/ 23
(Prevención del comportamiento suicida en el personal del Ejército Argentino).

Ejército Argentino
Unidad

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

Las siguientes planillas destinadas a Estadísticas médicas, serán llenadas por el personal de salud más antiguo del Elemento de Sanidad.

Planilla de Tentativa de Intención de Suicidio / Autolesión

Número	Grado	Genero	Edad	CIE 10: Diagnóstico Psiquiátrico (1)	Se encuentra bajo tratamiento (2)		Observaciones
					SI	NO	
1							
2							
3							
4							

(1) CIE 10: Según la Organización Mundial de la Salud.

(2) Tratamiento Psiquiátrico y/o Psicológico: Completar con una x en el caso que corresponda.

Ejército Argentino
Unidad

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Planilla de Mortalidad por Suicidio

Número	Grado	Genero	Edad	CIE 10: Diagnóstico Psiquiátrico (1)	Método de Suicidio Utilizado (*)	Se encuentra bajo tratamiento (2)		Observaciones
						SI	NO	
01								SI
02								
03								
04								

(*) Método de suicidio utilizado: disparo de arma de fuego/arma blanca/envenenamiento/ahorcamiento/salto desde un lugar elevado/otros.

DGS	
DPTO TEC	
	297
	124



General de Brigada JAVIER ALBERTO PALAZON
DIRECTOR GENERAL DE SALUD

DISTRIBUIDOR
El del cuerpo de la Directiva.